

Rapport de Situation de la 17^e Épidémie de la maladie à Virus Ebola / RDC

SitRep N°140/MVE-BDBV/01/10/2026

Date du rapport : 01 octobre 2026

Date de publication : 02 octobre 2026



FAITS SAILLANTS (dernières 24h)

- Septante -six 76 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE), dont 19 décès communautaires ont été notifiés. Ces cas provenaient des provinces de l'Ituri (49 cas), du Nord-Kivu (23 cas), du Haut-Uélé (3 cas) et (1) de la Tshopo. De plus, 5 décès ont été enregistrés dans les CTE.
- Un total de 452 nouveaux échantillons a été analysé; 76 de ces échantillons se sont révélés positifs au virus Bundibugyo, soit 16,8 % de positivité.
- Aucune nouvelle zone de santé n'a notifié de cas confirmé au cours des dernières 24 heures.

CUMUL DES
CAS
8 376

CUMUL DES
DÉCÈS
CONFIRMÉS
4 042

LÉTALITÉ
48,3 %

PATIENTS EN
ISOLEMENT/CTE
869

CUMUL DES
GUÉRIS
2 182

TAUX DE SUIVI DES
CONTACTS
(Du Jour)
81,3 %


Provinces touchées et zones de santé touchées


7 Provinces touchées
Haut-Uélé, Ituri, Nord-Kivu,
Sud-Kivu, Tshopo, Bas-Uélé et
Sud Ubangi

63 Zones de santé
touchées sur 167
(37,7%)

Résumé des points clés au cours des dernières 24 heures

Au terme des dernières 24h, 76 nouveaux cas confirmés de la Maladie à Virus Ebola (MVE) dont 19 décès communautaires ont été notifiés dans 4 provinces. Les provinces ayant rapporté ces cas sont l'Ituri (49 cas), le Nord-Kivu (23 cas), le Haut-Uélé (3 cas) et la Tshopo (1 cas).

De plus, 5 décès ont été enregistrés dans les CTE (4 en Ituri et 1 au Nord-Kivu), ce qui porte à 24 le nombre total des décès confirmés pour la période considérée.

Cependant, 20 patients (19 en Ituri, 1 au Nord-Kivu) ont été déclarés guéris après avoir obtenu deux résultats négatifs à la MVE.

Au 01 octobre 2026, la RDC cumule 8 376 cas confirmés et 4 042 décès (létalité : 48,3 %). L'Ituri demeure l'épicentre de l'épidémie avec 75,7 % des cas confirmés cumulés rapportés et 64,5 % des nouveaux cas confirmés. En revanche, la province du Nord-Kivu présente une létalité supérieure à la moyenne nationale, soit 59,0%.

Au total, 63 zones de santé sur 167 (37,7 %), réparties dans sept provinces, ont été touchées depuis le début de l'épidémie.

Tableau 1. Répartition des cas et décès confirmés par province touchée, au 01 octobre 2026.

Province	Nouveaux cas confirmés(24h)	Cas confirmés	Décès (confirmés)	Létalité	Zones de santé touchées
Ituri	49	6342	2 918	46,0%	28/36 (77,8 %)
Nord-Kivu	23	1624	958	59,0%	16/34 (47,1 %)
Haut-Uélé	3	349	144	41,3%	7/13 (53,8 %)
Tshopo	1	46	16	34,8%	7/23 (30,4 %)
Sud-Kivu	0	3	1	33,3%	1/34 (2,9 %)
Bas-Uélé	0	10	4	40,0%	3/11 (27,3%)
Sud Ubangi	0	2	1	50,0%	1/16 (6,3%)
Total	76	8 376	4 042	48,3%	63/167 (37,7 %)

Tableau 2. Répartition des cas et décès confirmés par province et zone au 01 octobre 2026

Province / Zone de santé	Nombre cumulatif			Situation du jour (24h)			
	Cas (n)	Décès (n)	Létalité	Nouv. Cas	Décès communautaires (Swab+)	Décès confirmés intra-CTE	Total décès confirmés
Ituri	6342	2918	46,0%	49	12	4	16
Adja	11	1	9,1%				0
Aru	8	6	75,0%				0
Ariwara	8	2	25,0%				0
Aungba	12	5	41,7%				0
Bambu	202	46	22,8%				0
Boga	2	2	100,0%				0
Bunia	1754	572	32,6%	15	5	1	6
Damas	40	9	22,5%				0
Drodro	15	7	46,7%				0
Fataki	82	31	37,8%				0
Gethy	7	3	42,9%				0
Kambala	2	0	0,0%				0
Kilo	37	12	32,4%				0
Komanda	170	104	61,2%	1	1		1
Lita	288	145	50,3%	1	0	0	0
Logo	13	5	38,5%				0
Lolwa	34	9	26,5%				0
Mahagi	4	1	25,0%				0
Mambasa	32	12	37,5%			1	1
Mandima	152	79	52,0%	14	4	0	4
Mangala	362	156	43,1%	5	2	0	2
Mongbwalu	705	333	47,2%	2	0	0	0
Nia-Nia	305	167	54,8%				0

Nizi	783	280	35,8%	2	0	1	1
Nyankunde	129	37	28,7%				0
Rimba	12	4	33,3%				0
Rwampara	1097	372	33,9%	9		1	1
Tchomia	76	25	32,9%				0
A ventiler	AN	493	NA				0
Nord-Kivu	1624	958	59,0%	23	7	1	8
Beni	367	243	66,2%	6	4		4
Biena	19	7	36,8%				0
Butembo	270	173	64,1%	3	1	1	2
Goma	1	0	0,0%				0
Kalunguta	57	19	33,3%	1	0		0
Katwa	571	359	62,9%	5			0
Kayna	1	0	0,0%				0
Kyondo	33	20	60,6%				0
Lubero	21	11	52,4%				0
Mabalako	38	14	36,8%	2	0		0
Manguredjipa	13	5	38,5%				0
Masereka	31	10	32,3%	2	0		0
Musienene	126	68	54,0%				0
Mutwanga	15	3	20,0%	1	1		1
Oicha	29	16	55,2%	2	1		1
Vuhovi	32	10	31,3%	1			0
Haut-Uélé	349	144	41,3%	3	0	0	0
Boma Mangbetu	41	17	41,5%	2	0	0	0
Dungu	1	1	100,0%				0
Gombari	3	1	33,3%				0
Isiro	102	44	43,1%				0
Pawa	87	39	44,8%				0
Rungu	3	1	33,3%	1	0	0	0
Wamba	112	41	36,6%				0
Tshopo	46	16	34,8%	1	0	0	0
Bafwasende	7	1	14,3%				0
Kabondo	5	1	20,0%				0
Lubunga	1	0	0,0%				0
Makiso-Kisangani	25	10	40,0%	1	0	0	0
Mangobo	6	3	50,0%				0
Tshopo	1	0	0,0%				0
Wanie-Rukula	1	1	100,0%				0
Sud-Kivu	3	1	33,3%	0	0	0	0
Miti-Murhesa	3	1	33,3%				0
Bas Uélé	10	4	40,0%	0	0	0	0
Buta	1	1	100,0%				0

Viadana	6	1	16,7%				0
Ganga	3	2	66,7%				0
Sud Ubangi	2	1	50,0%	0	0	0	0
Bulu	2	1	50,0%				0
Total	8376	4042	48,3%	76	19	5	24

*Il s'agit des décès confirmés survenus dans les différents CTE de la province qui sont en cours de ventilation pour être classifiés par zone de santé.

NA : Non Applicable.

Tableau 3. Situation des alertes notifiées par province pour la journée du 01 octobre 2026

DPS	Alertes Reçues		Total alertes	Alertes vérifiées et validées (cas suspect)		Alertes vérifiées et invalidées (non-cas suspect)		Nombre de suspects investigués	Nombre de suspects investigués et transférés au CT/CTE (du jour)
	Vivants	Décédés		Vivants	Décédés	Vivants	Décédés		
Haut-Uélé	39	4	43	27	4	12	0	31	18
Bas Uélé	157	4	161	29	3	129	0	32	0
Ituri	927	81	1008	176	79	743	1	255	137
Nord-Kivu	1 041	39	1080	140	39	862	0	179	100
Sud Ubangi	56	1	57	3	1	53	0	4	0
Tshopo	91	2	92	11	2	79	0	13	0
Total Général	2 311	91	2 441	386	128	1 878	1	514	255

Figure 1. Évolution de cas par date de début des symptômes au cours des 21 derniers jours

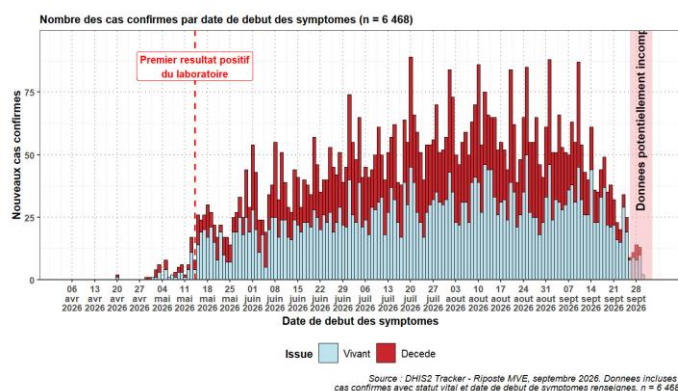
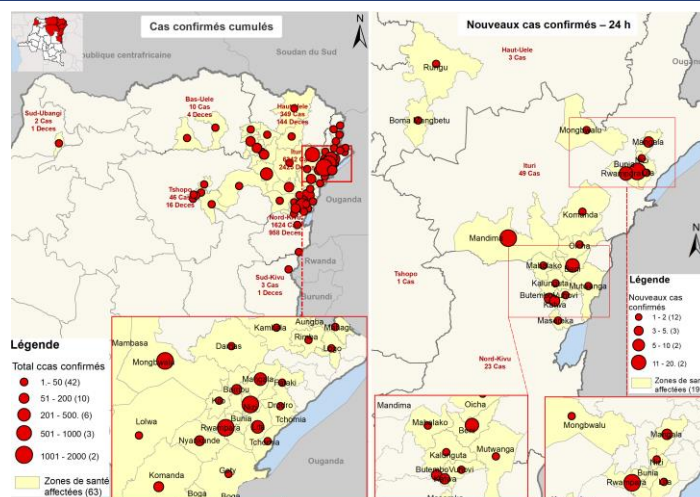


Figure 2. Distribution spatiale des cas confirmés (24 heures et cumuls) par zone de santé.



1. COORDINATION

1.1. Principales Actions

- Appui aux activités de réponse dans les provinces affectées à travers les piliers techniques.

2. ACTIONS DE RIPOSTE PAR PILIER

2.1. Surveillance épidémiologique

2.1.1. Principales Actions

Au terme de la journée du 01 octobre 2026, **2 402 alertes** ont été remontées, **2 393** (99,6 %) ont été vérifiées dont **514** (21,5 %) validées comme cas suspects. Parmi ceux-ci, **514** (100%) ont été investigués. Ainsi, 255 cas suspects ont été transférés vers les CT/CTE ([Tableau 3](#)).

Parmi **31 092** contacts en cours de suivi, **25 277** contacts ont été vus au cours des dernières 24 heures, soit une proportion de suivi de **81,3 %**, légèrement supérieure à celle de la veille (80,6%) mais demeurant inférieure au seuil requis (95,0 %). Cette proportion était de 90,3 % (167/185) au (Bas Uélé), 87,2% (34/39) au Sud Ubangi, 87,1% (660/758) à la Tshopo, 84,9% (882/1 039) au (Haut Uélé), 83,4 % (12 169/14 591) en Ituri, 78,5 % (11 365/14 480) au Nord Kivu.

2.2. Point sur les activités de points de contrôle et points d'entrées (PoE/PoC)

2.2.1. Principales actions

Sept (7) alertes ont été notifiées aux PoE/PoC au cours de la journée, dont six (6) en Ituri et une (1) au Nord-Kivu. En Ituri, au PoC Epulu Zunguluka (ZS de Mambasa), quatre alertes ont été validées : trois suspects ont été transférés au CTE de l'HGR Mambasa et le quatrième a choisi de poursuivre ses soins à Mangina (taux de transfert de 75,0 %) ; au PoC Dele (ZS de Rwampara), un corps sans vie a été intercepté et acheminé à la morgue pour le swab, et l'alerte du PoC Mabakese a été invalidée après le dépistage secondaire. Au Nord-Kivu, l'alerte du PoC Maboya (ZS de Kalunguta) a été validée et la patiente référée au CH Tinge

Tableau 4. Situation indicateurs clés des PoE/PoC par province, en date du 01 octobre 2026

Indicateurs	Ituri	Nord-Kivu	Tshopo	Global
Complétude des rapports	98,3% (59/60)	95,2% (20/21)	100,0% (18/18)	98,0% (97/99)
% des PoE/PoC stratégiques fonctionnels	100%	100%	100%	100%
Nombre de personnes passées aux PoE/PoC	152 190	100 612	22 301	275 103
% des voyageurs screenés	97,9%	97,8%	98,5%	97,9%
% des voyageurs ayant lavé les mains	97,5%	97,8%	98,0%	97,6%
% des voyageurs sensibilisés	99,5%	97,8%	100,0%	98,9%
Nombre d'alertes notifiées	6	1	0	7
Nombre d'alertes vivantes validées (cas suspects)	4	1	0	5
Nombre de corps sans vie interceptés ce jour	1	0	0	1
% des cas suspects transférés au CTE/CT	75,0%	100,0%	NA	80,0%
% des corps sans vie swabés/sécurisés	100,0%	NA	NA	100,0%
% des cas suspects investigués dans 4 h	100,0%	100,0%	NA	100,0%

2.3. Laboratoire

2.3.1. Principales actions

- **Ituri : 49 nouveaux résultats positifs** (37 vivants et 12 décès) sur 291 échantillons reçus et analysés (**positivité : 16,8 %**).
- **Nord-Kivu : 23 nouveaux résultats positifs** (16 vivants et 7 décès) sur 142 échantillons reçus et analysés (**positivité : 16,2 %**).
- **Haut-Uélé : 3 nouveaux résultats positifs** (3 vivants et 0 décès) sur 8 échantillons reçus et analysés (**positivité : 37,5 %**).
- **Tshopo : 1 nouveau résultat positif reçu** (1 vivant), sur 11 échantillons reçus et analysés (**positivité : 9,1 %**).
- **Bas Uélé : 18 échantillons** prélevés ont été acheminés au laboratoire d'Isiro, résultats en attente.

2.4. Prévention et Contrôle de l'Infection (PCI/EDS)

2.4.1. Principales actions

- **Ituri** : 18 rings ont été ouverts sur 29 (62,1 %), 37 ménages décontaminés sur 38 (97,4 %) et 5 FOSSA décontaminées sur 5 (100 %). Sur 92 alertes EDS (dont 4 reports), 57 EDS ont été réalisés (62,0 %) et 63 corps swabés ; aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits PCI.
- **Nord-Kivu** : 16 rings ont été ouverts sur 18 (88,9 %), 10 ménages décontaminés sur 24 (41,7 %) et 11 ESS décontaminées sur 13 (84,6 %). Au total, 334 ESS ont été suivies et 393 prestataires briefés ; aucun ménage décontaminé n'a été doté en kit.
- **Haut-Uélé** : 2 rings ont été ouverts sur 2 (100 %), 9 ménages décontaminés sur 9 (100 %) et 2 ESS décontaminées sur 2 (100 %). Sur 6 alertes EDS, 5 EDS ont été réalisés (83,3 %) et 5 corps swabés à Isiro et à Wamba ; l'UNICEF a doté la ZS d'Isiro de 2 véhicules et d'un kit de décontamination.
- **Tshopo** : 16 ESS ont été suivies dans 6 ZS et 173 prestataires briefés (100 %) ; la formation intégrée de 150 PPL des ESS privés se poursuit à Makiso-Kisangani. En cumul, 36 ESS sur 36 (100 %) et 27 ménages sur 31 (87,1 %) ayant accueilli un cas confirmé ont été décontaminés dans les 48 heures. Quatre corps sur six admis aux morgues ont été swabés, sans EDS réalisé.
- **Bas-Uélé** : 8 ESS sur 9 (88,9 %) ont été suivies à Viadana, Buta et Ganga et 29 prestataires sur 30 briefés (96,7 %) et 3 triages sur 4 (75,0 %) sont fonctionnels à Buta. Sur 4 alertes de décès, 3 corps ont été swabés, sans EDS réalisé.

2.4.2. Défis

En **Ituri**, l'ouverture des rings demeure insuffisante (62,1 % ; 18/29), 27 corps n'ont pas été swabés faute d'intrants et d'équipes à Mandima ou à la suite de refus des familles, des résistances persistent à Nizi et aucun ménage, ESS ni école n'a été doté en kits. Au **Nord-Kivu**, la décontamination des ménages reste faible (41,7 % ; 10/24) du fait des résistances communautaires et du manque d'équipes et de mobilité. À la **Tshopo**, l'insuffisance des intrants PCI dans les ESS et la panne de l'incinérateur de l'HGR Makiso-Kisangani persistent. Au **Bas-Uélé**, le CS Triangle ne dispose ni de zone à déchets fonctionnelle ni de latrines hygiéniques, et une forte résistance au swab persiste dans l'AS Bomea (ZS de Buta).

2.5. Prise en charge holistique

2.5.1. Principales actions

- En **Ituri**, 100 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 108 sorties, dont 19 guérisons. Au total, 394 patients demeuraient en isolement à la fin de la journée. Le taux d'occupation des lits était de **38,8 %** ; 346 patients sur 375 (92,3 %) ont bénéficié de repas chauds et les enfants sous LNPE/SLM ont été intégralement couverts au CTE (13/13), à la crèche (5/5) et dans la communauté (50/50) ; 27 malades sont en état critique.
- Au **Nord-Kivu**, 71 nouvelles admissions ont été enregistrées contre 57 sorties (1 guéries). Au total, 383 patients demeuraient hospitalisés dont 271 dans les structures normées. Le taux d'occupation des lits était de **63,0%** ; 21 malades étaient en état critique au CTE de Beni.
- À la **Tshopo**, 2 nouvelles admissions (1 confirmé et 1 suspect) ont été enregistrées. Aucune sortie n'a été rapportée. Douze (12) patients demeuraient en isolement à la fin de la journée, soit un taux d'occupation de 38,7 %.
- Au **Bas-Uélé**, 2 nouvelles admissions de suspects ont été enregistrées au CT de Limba (ZS de Viadana) contre 3 sorties de suspects déclarés non-cas à Buta. Six (6) patients demeuraient en isolement à la fin de la journée.
- Au **Haut-Uélé**, 11 nouvelles admissions ont été enregistrées. Au total, 74 patients sont en isolement dans les CTE, soit un taux d'occupation de **53,6 %**.

2.5.2. Défis

- En **Ituri**, capacité d'accueil insuffisante de certains CTE/CT et l'insuffisance de la prise en charge alimentaire demeurent préoccupantes.
- Au **Bas-Uélé**, l'absence de CTE normé et d'ambulance pour le transfert des malades demeure un défi opérationnel majeur.

- **À la Tshopo**, la présence continue de cas confirmés en isolement nécessite le maintien des mesures de prévention et contrôle de l'infection.

2.6. Vaccination

2.6.1. Principales actions

- **Au Bas-Uélé**, 25 PPL et TPL ont été vaccinés à Buta et la vaccination compassionnelle a démarré dans la ZS d'Aketi (11 vaccinés), portant le cumul provincial à 1 071 personnes vaccinées sur une cible de 13 202 (8,1 %), principalement à Buta (610 ; 21,3 %) et à Ganga (273 ; 20,5 %).

2.6.2. Défis

En Ituri, la cible des PPL/TPL reste à redéfinir, ce qui empêche le calcul d'un taux de couverture fiable.

Au Bas-Uélé, mise en marche des UCC non effective, pas de disponibilité du micro-plan validé et des fonds de la vaccination.

2.7. Continuité des Soins

2.7.1. Principales actions

- **À la Tshopo**, l'évaluation du CS Zawadi a relevé l'absence de certains registres (CPS et CPN), une vaccination du personnel limitée à 3 agents sur 9 (33,3 %) et une zone de triage non effective ; le plan de redressement de la Polyclinique Céleste a été élaboré.

2.8. Communication sur les risques et engagement communautaire (CREC)

2.8.1. Principales actions

- **En Ituri**, 22 619 visites à domicile ont touché 56 036 personnes ; 460 causeries éducatives ont réuni 7 760 personnes, 50 débats communautaires ayant touchés 923 personnes et 75 sensibilisations de masse 5 119 personnes. Au total, 259 alertes communautaires, dont 59 décès, ont été notifiées ; 58 feedbacks sur 90 (64,4 %) et 8 incidents sur 9 (88,9 %) ont été résolus dans les 48 heures (complétude de 9 ZS sur 28, soit 32,1 %).
- **Au Nord-Kivu**, 13 038 visites à domicile ont touché 45 515 personnes, 89 causeries éducatives 4 479 personnes et 38 séances de communication de masse 7 648 personnes ; 256 alertes communautaires sur 650 attendues (39,4 %) ont été notifiées, et 17 feedbacks sur 23 (73,9 %) ainsi que les 5 incidents enregistrés ont été résolus dans les 48 heures.
- **À la Tshopo**, 198 visites à domicile ont touché 1 410 personnes, 2 causeries éducatives 161 personnes et 8 séances de sensibilisation de masse 4 377 personnes ; 13 alertes communautaires ont été notifiées (8 à Bafwasende, 3 à Kabondo et 2 à Tshopo) et les 2 feedbacks reçus ont été résolus (2/2).
- **Au Bas-Uélé**, 200 visites à domicile ont touché 1 275 personnes, 8 causeries éducatives 123 personnes et 10 sensibilisations de masse 1 800 personnes à Viadana, Titule et Ganga ; les 9 alertes communautaires notifiées à Ganga ont été traitées).

2.9. Santé mentale et soutien psychosocial (SMSPS)

2.9.1. Principales actions

- **Nord-Kivu**, 25 cas confirmés sur 31 (80,6 %) enregistrés la veille et 246 cas confirmés en cours de suivi ont bénéficié d'interventions SMSPS dans 7 ZS sur 8 ayant notifié (87,5 %). Les équipes ont pris en charge 112 nouveaux suspects et 406 suspects en cours de suivi, accompagné les 34 ménages d'enfants séparés et orphelins (100 %), annoncé 108 résultats, dont 12 positifs, et réinséré 8 guéris.
- **En Ituri**, 34 cas confirmés sur 44 (77,3 %) de la veille, 126 confirmés en cours de suivi sur 133 (94,7 %), 57 nouveaux suspects sur 100 (57,0 %) et 122 suspects en cours de suivi sur 133 (91,7 %) ont bénéficié d'interventions SMSPS. Les équipes ont soutenu 447 accompagnants et 78 PPL et annoncé 56 résultats, dont 34 positifs.
- **À la Tshopo**, les équipes ont apporté un soutien psychologique à 3 cas confirmés au CTE Météo, dont 1 nouveau, réalisé la psychoéducation de 10 suspects et de 196 personnes, dont 117 médecins stagiaires aux CUKIS, et annoncé 3 résultats, dont 1 positif.

2.9.2. Défis

- **En Ituri**, 13 ZS affectées sur 28 sont couvertes (46,4 %) ; la couverture autour des derniers cas reste faible à Nia-Nia (2/7 ; 28,6 %), où les interventions SMSPS autour des décès communautaires doivent être renforcées.
- **Au Haut-Uélé**, difficultés de mobilité des APS à Wamba et Boma Mangbetu, insuffisance de kits nutritionnels pour les nourrissons sevrés et faible remontée des données à Pawa et Boma Mangbetu.
- **À la Tshopo**, nécessité de former les APS des ZS de Wanie-Rukula et de Bafwasende et insuffisance des moyens de communication et de déplacement du pilier.

2.10. Logistique

2.10.1. Principales actions

- **À la Tshopo** réception de 2 véhicules de location pour 42 jours (MOMENTUM), suivi de la construction de l'isolement de Kongakonga, du CTE de Bafwasende et de l'extension du CTE Météo.
- **Au Bas-Uélé**, déploiement des équipes de surveillance à Ganga et à Viadana, poursuite de la réhabilitation de la salle de réunion et des bureaux de la DPS (OMS) et de la construction du centre de transit de l'HGR de Buta ; le stock de chlore est limité à 25 kg et le gasoil est en rupture.

2.11. Sécurité

2.11.1. Principales actions

- **Au Nord-Kivu**, le pilier Mitigation des risques et sécurité a réalisé 2 activités de couverture sécuritaire (100 %), dont l'accompagnement de l'équipe EDS pour l'enterrement d'un cas confirmé à Bundji, et a rétabli l'ordre à la morgue de l'HGR de Beni, où une famille tentait de récupérer par la force le corps d'un cas confirmé).

2.12. PSEA (Prévention de l'Exploitation et Abus Sexuels)

2.12.1. Principales actions

- **En Ituri**, 24 membres du personnel (17 hommes et 7 femmes) ont été briefés sur la PSEAH et ont signé le code de bonne conduite à Bunia ; seules 13 ZS sur 36 (36,1 %) connaissent le mécanisme de signalement.
- **Au Haut-Uélé**, 29 PPL de l'AS de Mayogo (ZS d'Isiro), dont 19 femmes, ont été briefés sur la PSEAH et 63 personnes, dont 36 femmes enceintes reçues en CPN au CS VDO, ont été sensibilisées à Wamba et à Isiro.

2.12.2. Défis

Au niveau national, seules 2 DPS ont rapporté leurs activités PSEA (28,6 %) et les CBCM restent peu efficaces.

MESSAGES CLES

- Une transmission communautaire active et soutenue demeure observée dans les provinces de l'Ituri, du Nord-Kivu, du Haut-Uélé. Tandis que la province du Sud Ubangi n'a notifié aucun cas confirmé au cours des dernières 24 heures et une accalmie est observée dans la province de la Tshopo par rapport aux 72 dernières heures.
- Des progrès à consolider sont enregistrés dans le domaine des investigations épidémiologiques : La quasi-totalité (**100 %**) des cas suspects a été investiguée dans les 24 heures suivant leur notification. Toutefois, le taux de suivi des contacts est supérieur par rapport à la veille (**81,3 vs 80,6%**). Cependant, les efforts doivent être fournis afin que ce taux atteigne le seuil requis (95 %).
- Renforcer la surveillance, la prise en charge, la PCI, la logistique et l'engagement communautaire, en privilégiant l'augmentation des capacités des CTE/CT au Nord-Kivu, le transfert rapide des suspects et l'isolement des cas confirmés.
- Renforcer la préparation et la réponse à la MVE-B dans le corridor fluvial et les zones environnantes, notamment au Sud-Ubangi, par la recherche active, le suivi des contacts et la disponibilité des intrants. Poursuivre la surveillance transfrontalière avec le Soudan du Sud.

CHRONOLOGIE DES FAITS CLÉS

- Du 24 avril au 15 mai 2026, l'épidémie est passée de la détection des premiers cas suspects à la confirmation biologique du virus Ebola Bundibugyo, conduisant à la déclaration officielle de la 17^e épidémie de Maladie à Virus Ebola en République Démocratique du Congo.
- Entre le 17 et le 18 mai 2026, les autorités nationales, avec l'appui des partenaires, ont renforcé la riposte par la déclaration de l'urgence de santé publique de portée nationale puis continentale, accompagnée de la mobilisation des fonds.



TASK FORCE PRESIDENTIELLE EBOLA 17
Ministère de la Santé Publique, Hygiène et Prévoyance Sociale
Institut National de Santé Publique
Centre d'Opérations d'Urgence de Santé Publique
Système de gestion de l'incident MVE17

Directeur Général de l'INSP

Dr MWAMBA KAZADI Dieudonné

E-mail : dieudonne.mwamba@insp.cd

Incident Manager

Professeur Dr AHUKA MUNDEKE Steve

E-mail : steve.ahuka@unikin.ac.cd

Chargé des opérations

Dr KOMBE NGWAMA John

Equipe de rédaction

Professeur Dr MULANGU KATULUMBA Félix-Médard

Dr KATUSI BISELENGE Jules

Madame MAYELE AFUA Marie

Dr DIUR MANANASHI Floryan

Mr KAMUINA KEBELA John

Contact :

www.insp.cd

contact@sgiebola17.org

Numéro vert : 151. www.sante.gouv.cd